KIT 5 – SEPSE / DETERIORAÇÃO CLÍNICA

Referências: ABRAMEDE 2024 • ILAS 2023 • Surviving Sepsis Campaign 2021 • Ministério da Saúde – Protocolo Nacional de Sepse

Objetivo

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem em pacientes com suspeita de sepse, choque séptico ou deterioração clínica aguda, garantindo o diagnóstico precoce, a estratificação de gravidade e a racionalização de recursos diagnósticos no pronto-socorro.

1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA

- Considerar **sepse** em pacientes com infecção suspeita ou confirmada + **disfunção orgânica** (SOFA ≥ 2 pontos).
- Identificar **sinais de deterioração clínica**: hipotensão, taquicardia, taquipneia, rebaixamento do nível de consciência, hipoxemia ou oligúria.
- Realizar **avaliação imediata de via aérea, ventilação e perfusão**.
- Acionar **Protocolo de Sepse e de Deterioração Clínica** conforme fluxos institucionais.

2. EXAMES LABORATORIAIS

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Hemograma completo	Todos os pacientes com suspeita de infecção, sepse ou deterioração.	—
Gasometria arterial / venosa + lactato	Avaliação de oxigenação, acidose e hipoperfusão; controle seriado a cada 2–4h.	Casos estáveis sem sinais de hipóxia ou choque.
Ureia / Creatinina / Eletrólitos	Avaliar função renal e distúrbios metabólicos; fundamental no cálculo do SOFA.	Casos leves sem disfunção orgânica.
TGO / TGP / Bilirrubinas / FA / GGT	Avaliação de função hepática e disfunção multiorgânica.	Casos sem repercussão sistêmica.
Coagulograma (TP, TTPA, INR, fibrinogênio, plaquetas)	Suspeita de CIVD, disfunção hepática ou sepse grave.	Casos leves sem alteração clínica.
PCR / Procalcitonina	Diagnóstico diferencial e monitoramento da resposta terapêutica.	Casos sem suspeita infecciosa.
Glicemia capilar	Monitorização contínua da resposta metabólica e uso de insulina.	—
Urocultura, Hemoculturas (2 pares) e Culturas de sítio suspeito	Coletar **antes do início do antibiótico**, preferencialmente de 2 sítios diferentes.	Não adiar antibioticoterapia se coleta inviável.
Albumina e Proteínas totais	Avaliar estado nutricional e prognóstico.	Casos com diagnóstico infeccioso leve.
Troponina e BNP	Pacientes com disfunção miocárdica séptica, choque misto ou comorbidades cardíacas.	Casos sem instabilidade hemodinâmica.

3. EXAMES DE IMAGEM

Exame	Indicação	Evitar / Não Indicado
RX de Tórax	Suspeita de pneumonia, foco pulmonar, controle de dispositivos invasivos.	Casos sem sintomas respiratórios ou controle desnecessário.
USG abdominal total / POCUS	Avaliação de coleções, obstruções, abscessos, colestase, pielonefrite.	Casos com diagnóstico infeccioso já confirmado e sem novo foco.
USG cardíaco (POCUS)	Avaliação de função ventricular, tamponamento, hipovolemia e resposta volêmica.	Casos sem instabilidade hemodinâmica.

b) Segunda linha (complementar)

Exame	Indicação (Solicitar se)	Evitar / Não Indicado
TC de tórax / abdome / pelve com contraste	Suspeita de foco infeccioso oculto, abscesso, perfuração, coleções ou sepse sem foco definido.	Casos leves, diagnóstico clínico evidente.
TC de crânio sem contraste	Alteração neurológica aguda, rebaixamento inexplicado do nível de consciência.	Sem déficit focal ou alterações neurológicas.

4. ESCORES DE APOIO À DECISÃO

qSOFA (avaliação rápida de sepse)

Critério	Pontos
FR ≥ 22 irpm	1
PAS ≤ 100 mmHg	1
Alteração do nível de consciência (Glasgow < 15)	1

qSOFA ≥ 2 → suspeitar de sepse e iniciar protocolo imediatamente.

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)

- Inclui: PaO_2/FiO_2, plaquetas, bilirrubinas, PAM ou DVA, Glasgow, creatinina ou débito urinário.
- **SOFA ≥ 2** → confirma disfunção orgânica relacionada à infecção.

5. PRIORIDADES

- **Iniciar coleta de exames e culturas antes do antibiótico**, sem atrasar início da antibioticoterapia.
- Repetir **lactato** em 2–4 horas para avaliar resposta ao tratamento.
- Aplicar **escores (qSOFA / SOFA)** para monitoramento contínuo.
- Priorizar **USG e RX** como exames iniciais para foco infeccioso.
- Solicitar **TC com contraste** apenas após estabilização hemodinâmica.
- Registrar e reavaliar todos os parâmetros clínicos a cada 30–60 minutos em deterioração clínica ativa.

Resumo Prático:

Cenário Clínico	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
Sepse pulmonar / pneumonia	Hemograma, PCR, gasometria, lactato, eletrólitos, culturas	RX Tórax ± USG pulmonar
Sepse abdominal / foco indeterminado	Hemograma, função renal e hepática, lactato, culturas	USG abdome ± TC contrastada
Sepse urinária / urológica	EAS, urocultura, creatinina, hemograma	USG rins e vias urinárias
Choque séptico / deterioração grave	Gasometria seriada, lactato, SOFA, culturas, função orgânica completa	USG cardíaco e abdominal ± TC
Infecção leve / estável	Hemograma, PCR, urocultura se indicado	Nenhum exame adicional inicial

Conclusão

A abordagem laboratorial e de imagem na sepse deve ser **rápida, dirigida e baseada em critérios clínicos de gravidade**. O diagnóstico precoce e a coleta adequada de exames reduzem mortalidade e tempo de internação.

- ✅ Diagnóstico rápido e dirigido
- ✅ Detecção precoce da disfunção orgânica
- ✅ Uso racional de exames e contrastes
- ✅ Melhor desfecho clínico e prognóstico